# AutaMedica

Evaluación Psiquiátrica de Seguimiento

## Paciente no especificado (Requiere verificación previa)

Edad no consignada | Género no consignado | Documento generado: 09/04/2026

### I. IMPRESIÓN CLÍNICA INICIAL

Paciente se presenta refiriendo como motivo principal: "continuidad". Menciona diagnóstico previo de TDAH. Paciente refiere uso actual de metilfenidato con beneficio subjetivo reportado. No recuerda el profesional prescriptor o la información brindada es insuficiente. Dosis reportada: 2 mg dia.

ATENCIÓN: Se recomienda verificación activa de antecedente farmacológico antes de documentar continuidad terapéutica o prescribir.

### II. IMPACTO FUNCIONAL Y RESPUESTA SINTOMÁTICA

En cuanto al alivio de síntomas, la paciente refiere la siguiente experiencia subjetiva: "tengo mas atencion, no me distraigo, no me frusto, logro leer".
Sobre el impacto residual en su rutina (estudio, trabajo o dinámica en el hogar) expone: "sueno, trabajo, en casa, con la familia, duemo 18 horas y las 4 horas despierto pensando que como quieria dormr".
De manera global, describe su respuesta previa a la pauta farmacológica como: "me ayuda mucho".

### III. EVALUACIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD VITAL

El paciente negó dolor torácico asociado al uso, crisis de pánico y descartó ideas de autolesión actuales. Se constata reporte de insomnio actual o alteración severa del ciclo sueño-vigilia que requiere exploración clínica prioritaria.

### IV. SEMAFORIZACIÓN Y ALERTAS CLÍNICAS (Requiere revisión)

- Evaluación Clínica URGENTE (Protocolo de Contingencia): Uso crónico referido de estimulantes con prescriptor desconocido. REGLA OPERATIVA: 1) Prohibido el abandono (alto riesgo de daño por interrupción/depresión). 2) Resolución obligatoria HOY. 3) Proveer continuidad transitoria supervisada (puente clínico), con dosis base segura a definir por el médico tratante.
- Evaluación de Sueño Confusa / Severa: Reporte discordante o severo sobre la calidad de horas de sueño ("insomnio" sumado a reportes extensos de dormir). Evaluar hipótesis de efecto rebote o depresión comórbida.

### ANEXO DE CONTEXTO: RESPUESTAS ADICIONALES RELEVANTES

- OCUPACION ACTUAL: los2
- RUTINA PRINCIPAL: normal

- APETITO: menos_apetito
- ADHERENCIA: constante
- OBJETIVOS TRATAMIENTO: todo
- COMENTARIOS FINALES: no
- ANTECEDENTES RELEVANTES: ninguno
- CONTRAINDICACIONES: ninguna

*NOTA REGLAMENTARIA: Este documento es una automatización preliminar autogenerada a partir de las declaraciones subjetivas del paciente a través del portal de Triage Digital (Anamnesis asincrónica). No constituye un diagnóstico médico firme, no certifica discapacidad, ni reemplaza en ninguna medida el criterio soberano del profesional médico psiquiatra tratante durante la consulta clínica en vivo.*